

나와 가족을 위한 심방세동 예방과 관리 정보



대한의학회
Korean Association of Medical Professionals



질병관리청
Ministry of Health

발간등록번호
11-1790387-000967-01



나와 가족을 위한 심방세동 예방과 관리 정보

이 자료는 심방세동을 예방하고 관리하는 방법을 제시하고 있습니다. 모든 국민이 실천해야 할 8대 생활 수칙과 구체적인 방법을 알려 드립니다. 우리 모두 정기적으로 검진을 받고 올바른 생활 습관을 들여 심방세동을 예방합시다.

차례

제1장

심방세동 소개

- 05 심방세동의 뜻
- 06 우리나라 심방세동 환자 현황
- 07 심방세동을 주의해야 하는 이유
- 09 심방세동 원인, 증상, 진단
- 10 심방세동 치료와 관리

제2장

심방세동 예방과 관리 8대 생활 수칙

- 14 두근거림이 있으면 항상 맥박을 재거나 심전도 검사를 합니다
- 18 과음과 폭음을 삼갑니다
- 22 과도한 스트레스를 피합니다
- 28 고혈압이나 당뇨병 등과 같은 기저질환을 잘 관리합니다
- 34 수면 무호흡을 잘 관리합니다
- 38 금연을 합니다
- 42 비만을 관리합니다
- 48 심방세동으로 진단받으면 반드시 적절한 치료를 받습니다

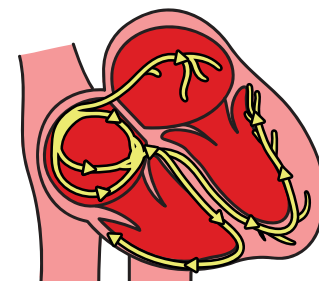
제3장

- 52 심방세동 관련 자주하는 질문
- 56 부록

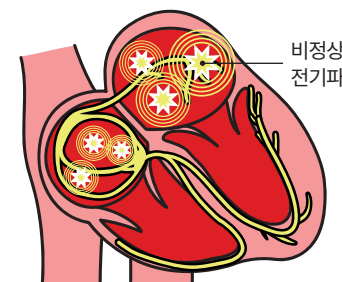
심방세동 소개

심방세동의 뜻

심장의 박동이나 리듬이 고르지 않은 것을 '부정맥'이라고 합니다. 심방세동은 부정맥의 한 종류로 심장 박동이 지속해서 불규칙하게 나타나는 것이 특징입니다. 맥박을 만져 보거나 혈압을 측정할 때 이상 상태가 관찰되며 스마트워치로 발견할 수 있습니다. 환자 대부분은 맥박이 불규칙하게 빨라지고, 가슴이 답답하며, 평소보다 숨이 차는 것을 느끼지만, 증상을 못 느끼는 환자도 있습니다. 주로 어르신에게서 관찰되지만, 드물게 50세 이전의 중장년층에게서도 발병합니다.



정상 심장



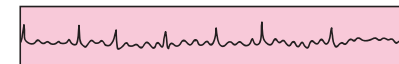
심방세동 환자의 비정상 심장

심방세동은 심전도 검사 결과로 진단합니다. 증상을 유발하는 것은 심장 박동이 빠르고 불규칙한 것인데, 이를 개선하고자 맥박수나 리듬을 조절하는 치료를 받습니다. 또한 치료에서 가장 중요한 부분은 뇌경색(중풍) 예방입니다. 뇌경색의 위험도를 평가하여 위험도가 높은 환자에게는 항응고제와 같은 약물을 처방합니다.

정상 심전도



심방세동 심전도



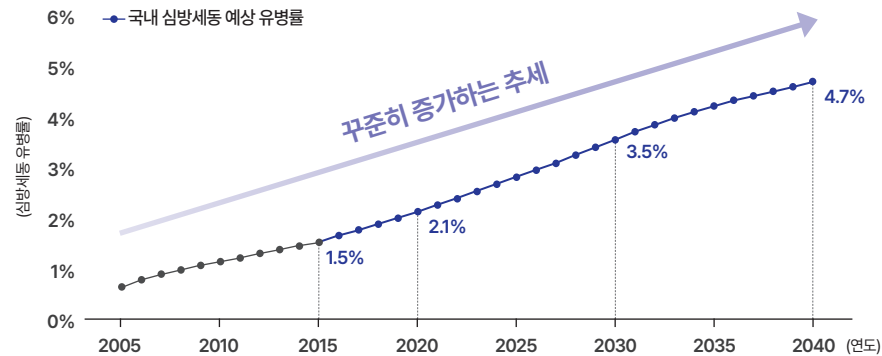
우리나라 심방세동 환자 현황

우리나라 성인 인구에서 심방세동 환자는 조금씩 늘어나고 있습니다.

19세 이상 성인 100명 중 2명이 심방세동 환자입니다. 심방세동 환자의 비율은 60대 인구에서는 100명 중 3명 정도이지만, 70대 인구에서는 100명 중 6명이고 80대 인구에서는 100명 중 8명 이상으로, 노인 인구에서 심방세동 환자가 더 많습니다.

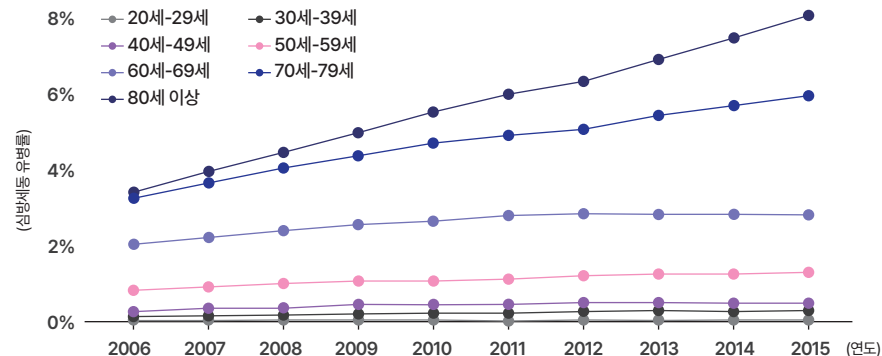
국내 심방세동 예상 유병률

출처 Kim D, et al. Am Heart J. 2018



연령별 심방세동 유병률

출처 Kim D, et al. Am Heart J. 2018

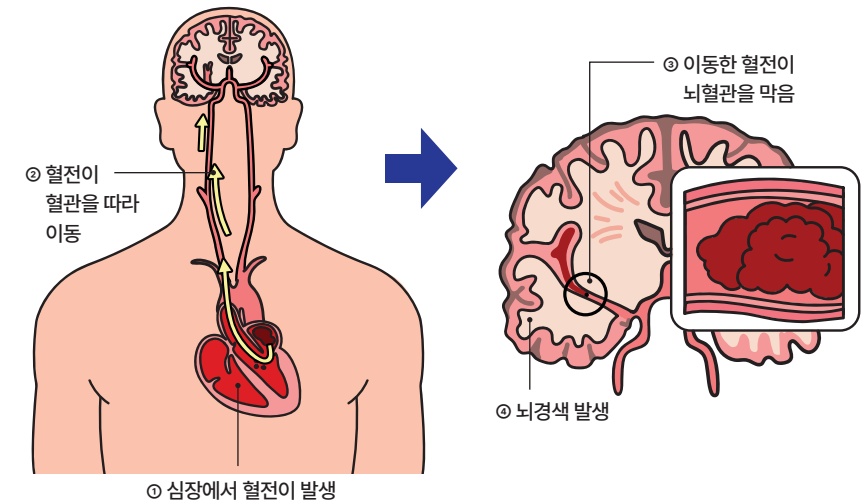


심방세동을 주의해야 하는 이유

심방세동이 발생하면 심장 안에 혈전이 잘 생기는데, 이때 생긴 혈전이 떨어져 나가면 온몸 어디로든 갈 수 있습니다. 특히 뇌혈관을 막아 뇌경색이 잘 생깁니다. 심방세동은 뇌경색의 원인 중 20~30%를 차지할 만큼 매우 비중이 큰 요인입니다. 심방세동이 있는 환자는 심방세동이 없는 사람보다 뇌졸중 발생 위험이 5배 정도 높은 것으로 알려져 있습니다.

심방세동으로 인한 뇌졸중은 다른 원인으로 생긴 뇌졸중보다 일반적으로 더 심하게 발생합니다. 따라서 뇌졸중 후유장애가 생길 가능성이 커서 내 몸을 내가 가누기 어려운 상태가 될 수 있습니다. 또한 심방세동으로 인지기능 장애가 생길 수 있습니다. 뇌졸중 발생 때문에 인지기능이 떨어지기도 하지만, 뇌졸중이 발생하지 않더라도 인지기능 장애의 위험은 1.5배 정도 높아집니다.

심장성색전뇌졸중



심방세동을 주의해야 하는 이유

심방세동 환자는 심방세동이 없는 사람보다 심장 문제로 인한 사망률이 2배 정도 높으며, 10명 중 2~3명은 심장 기능이 떨어지기도 합니다. 이에 따라 조금만 걸어도 숨쉬기 힘들거나, 무력감, 피곤함 등을 느끼기도 합니다. 또한 가슴이 두근거리거나 답답하며, 심할 때는 어지럽고 숨이 차기도 하는 심계항진을 느끼기도 합니다.

이렇듯 심방세동은 심방세동 자체뿐만 아니라, 심방세동에 따른 합병증으로 사회생활, 여가생활 등 일상에도 지장이 생길 수 있는 질환이므로 반드시 일찍 발견하여 치료하는 것이 중요합니다.

심방세동 원인, 증상, 진단

심방세동은 기본적으로 심장 자체의 전기적 특성으로 발생하기 때문에 '건강관리를 잘못해서' 생기는 것만은 아닌 질환입니다. 특히 고령이 되면 심장 자체에 변화가 오기 때문에 노년에 잘 발생하는 부정맥이라고 할 수 있습니다. 유전적 소인도 약하게 작용할 수는 있으나, 혈액형처럼 뚜렷하게 유전되는 질환은 아닙니다.

음주, 특히 과음과 폭음을 하거나 급성 스트레스가 있을 때 활발하게 촉발될 수 있습니다. 수면 무호흡, 고혈압, 비만, 폐 질환 등에서 심방세동이 잘 발생할 수 있습니다. 또한 당뇨병, 흡연 등은 간접적인 촉발 요인으로 작용할 수 있습니다.

심방세동이 생기면 심장이 불규칙하게 뛰며, 많은 수에서 심박이 빨라지므로 가슴이 두근거리는 증상으로 나타날 때가 많습니다. 걸을 때 숨이 차거나 가슴이 답답하고, 몸이 붓거나 어지럽고 피로한 증상이 동반될 수도 있습니다. 한편, 심방세동 환자 중 많은 수에서는 전혀 증상 없이 우연히 발견되기도 합니다. 검진을 하다가 우연히 발견되는 심방세동이 대표적이며, 특히 고령에서 증상 없이 우연히 발견될 때가 종종 있습니다.

심방세동을 비롯한 부정맥 질환은 오직 '심전도' 검사로 정확히 진단할 수 있습니다. 심전도는 심장의 전기적 활성을 그래프로 기록하는 검사로서 병원에서 팔목과 발목에 집게를 꽂고 가슴에 전극 여러 개를 붙여서 찍는 심전도 검사가 기본입니다. 24시간 또는 여러 날 동안 몸에 부착해 두고 기록하는 '홀터 심전도' 검사도 매우 유용합니다. 요즘 많이 사용하는 '스마트워치 심전도'로도 진단할 수 있으니 의심 증상이 있을 때는 최대한 빨리 심전도 검사를 해 보는 것이 좋습니다.

심방세동 치료와 관리

심방세동으로 진단되면 지속 단계에 따라 치료 방법을 결정합니다.

심방세동 발생 초기에는 심방세동 부정맥이 자연히 생겼다 없어졌다 하는 '발작성 심방세동' 형태로 나타납니다. 이 시기에는 우선 항부정맥 약물치료로 심장 박동이 정상 리듬을 유지할 수 있게 합니다. 약물치료를 했음에도 심방세동이 재발하면 고주파나 냉동 풍선 절제술과 같은 시술적 치료를 합니다.

심방세동이 '지속성 심방세동' 형태가 되면 항부정맥 약만으로 정상 리듬으로 조절되지 않을 수 있습니다. 이럴 때는 전기충격을 주어 정상 리듬으로 만든 다음 항부정맥 약물치료를 하다가, 조절이 안 되면 시술적 치료를 하기도 합니다.

심방세동이 오래되면 평생 지속되는 '영구적 심방세동' 상태가 되는데, 이때는 심방세동 자체를 없애려 하지 않고 심박수만 너무 빠르지 않게 하는 정도로 부정맥을 조절합니다.

이처럼 리듬을 조절하는 치료 외에 중요한 것으로는 심방세동으로 발생하는 뇌경색을 예방하는 '항응고' 치료가 있습니다. 심방세동을 잘 치료해야 하는 가장 중요한 이유는 뇌경색 예방인데, 이는 심장 안에 혈전이 생기지 않게 하는 항응고제를 사용하여 치료합니다. 나이가 젊고 동반 질환이 거의 없으면 뇌경색의 위험도가 매우 낮아 항응고제를 사용하지 않지만, 그 외 대부분은 항응고 약물치료가 필요합니다.

심방세동으로 진단받으면 전문의와 상의하여 적절한 치료를 받는 것이 무엇보다 중요합니다. 그 외에 금주, 금연, 체중 관리, 수면 무호흡 치료, 적절한 운동 등의 관리를 함께해야 합니다.

제2장

심방세동 예방과 관리 8대 생활 수칙

- 1 두근거림이 있으면 항상 맥박을 재거나 심전도 검사를 합니다
★★ 보통
- 2 과음과 폭음을 삼갑니다
★★★ 높음
- 3 과도한 스트레스를 피합니다
★★ 보통
- 4 고혈압이나 당뇨병 등과 같은 기저질환을 잘 관리합니다
★★★ 높음
- 5 수면 무호흡을 잘 관리합니다
★★★ 높음
- 6 금연을 합니다
★★★ 높음
- 7 비만을 관리합니다
★★★ 높음
- 8 심방세동으로 진단받으면 반드시 적절한 치료를 받습니다
★★★ 높음

★★★ 높음 체계적 문헌 고찰, 대조군이 있는 임상 연구

★★ 보통 코호트 연구, 환자-대조군 연구

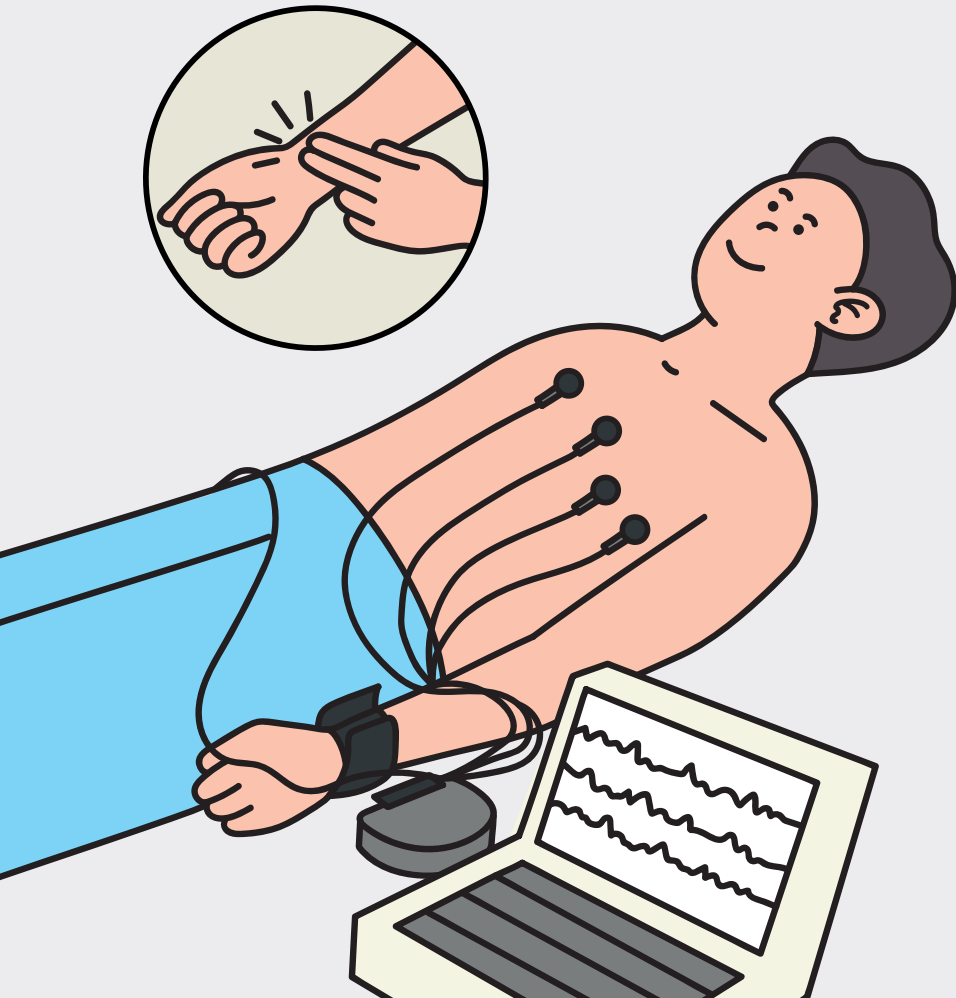
★ 낮음 대조군이 없는 단면 연구, 전문가 의견

이 생활 수칙을 만들고자 참고한 국내외 학술지에 게재된 논문 등의 연구 설계 방법에 따라 근거 수준을 높음, 보통, 낮음으로 표기하였습니다.

1

두근거림이 있으면 항상 맥박을 재거나 심전도 검사를 합니다

★★ 보통



실천 항목

- 가슴이 두근거릴 때 손목에 손가락을 가볍게 올려 맥박을 짍니다.
- 자동 혈압계가 있으면 이를 이용하여 맥박수를 잴 수 있습니다.
- 스마트워치가 있으면 이를 이용하여 맥박수나 심전도를 측정합니다.
- 두근거림이 지속되면 가까운 병원에 방문하여 심전도를 측정합니다.

관련 상식 들여다보기

- 심방세동의 특징은 '불규칙한 맥박'입니다. 맥박을 짚어서 심방세동인지 추정해 보려면 1분 동안의 맥박수뿐만 아니라, 맥박이 규칙적인지 불규칙적인지 확인하는 것이 중요합니다.
- 두근거리거나 맥박이 비정상일 때에는 심전도를 검사해야 합니다. 부정맥은 증상만으로 진단할 수 없고, 반드시 심전도 그래프를 보고 진단해야 합니다. 병원에 방문해서 검사하는 심전도, 휴대용 심전도 기기, 스마트워치 등 다양한 방법으로 심전도를 기록할 수 있습니다. 기록된 심전도를 가지고 부정맥 전문의와 상의합니다.

실천 방법 알기

가슴이 두근거릴 때 손목에 손가락을 가볍게 올려 맥박을 짍니다.

- 긴장을 풀고 편안한 자세를 취합니다.
- 손목 안쪽에 검지와 중지 끝부분을 올려놓습니다.
(그림 참고)



- 가볍게 눌러 맥박을 짍니다.
- 불규칙하지는 않은지 천천히 확인합니다.
- 맥의 강도가 충분하고 규칙적이면 30초 동안 맥박수를 짍니다.
- 맥의 강도나 리듬이 불규칙하면 1분 동안 측정합니다.

자동 혈압계가 있으면 이를 이용하여 맥박수를 짍 수 있습니다.

- 5분 정도 편안한 자세를 취하고 자동 디지털 혈압계 커프(가압대)를 심장 위치에 두고 가볍게 감아 줍니다. 혈압 측정을 시작하고 표시되는 맥박수를 기록합니다. 기기에 따라서는 불규칙한 맥박 여부를 표시해 줍니다.

스마트워치가 있으면 이를 이용하여 맥박수나 심전도를 측정합니다.

- 스마트워치의 사용 설명서에 따라서 맥박수나 심전도를 측정합니다. 다음에 전문의와 상담할 때 보여 줄 수 있게 인쇄해 두기를 권합니다.

두근거림이 지속되면 가까운 병원에 방문하여 심전도를 측정합니다.

참고 문헌

- ① Pickering D. How to measure the pulse. Community Eye Health 2013;26(82):37.
- ② Lin TT, Wang CL, Liao MT, et al. Agreement between automated and human measurements of heart rate in patients with atrial fibrillation. J Cardiovasc Nurs 2018;33(5):492-499.
- ③ Elliott KE, McCall KL, Fike DS, et al. Assessment of manual blood pressure and heart rate measurement skills of pharmacy students: a follow-up investigation. Am J Pharm Educ 2008;72(3):60.

과음과 폭음을 삼갑니다

★★★ 높음



실천 항목

- 술자리는 되도록 피합니다.
- 술은 하루에 3잔 이상 마시지 않습니다.
- 술을 마실 때 폭탄주와 '원샷'은 피합니다.

관련 상식 들여다보기

- 술은 심방세동 발생 위험도를 높일 수 있다는 여러 이론적 근거가 있습니다. 연구에 따르면, 알코올 섭취량이 하루 36g이 넘으면 심방세동 발생 확률이 유의미하게 증가한다고 보고되고 있습니다. 알코올 36g은 주종에 상관없이 술 3잔 정도에 해당하는 양으로, 생각보다 적은 양의 음주로도 심방세동 발생 위험도가 올라갈 수 있습니다.
- 과음과 심방세동의 연관성은 남자에게서 더 많이 관찰된다고 알려져 있으므로 사회생활이 활발한 일반 남자는 주의해야 합니다. 다만, 65세 이상 노인을 대상으로 한 연구 결과를 보면 하루 1~2잔의 음주는 심방세동과 무관한 것으로 추정되지만, 그렇다고 해서 음주를 특별히 권장할 이유는 되지 않는다는 점을 명심해야 합니다.
- 술과 관련한 의학적 연구 방법의 한계로 명확한 판단이 쉽지는 않지만, 이상의 결과들을 종합하여 볼 때, 과도한 음주는 심방세동 발생 위험을 높일 가능성이 있는 것으로 판단됩니다.

실천 방법 알기

술자리는 되도록 피합니다.

- 술자리를 되도록 피해야 하는 이유는 우리나라 음주 문화상 술자리에서 음주량을 스스로 조절하기 쉽지 않기 때문입니다. 그뿐만 아니라, 비록 하루 한두 잔의 소량 음주가 심방세동과 연관성이 높지 않다고 하더라도, 완전 금주보다 간암, 대장암 등 암 발병률을 높이는 것으로 알려져 있습니다. 2016년에 개정된 '국민 암 예방 수칙(보건복지부·국립암센터)'에도 '하루 1~2잔의 소량 음주도 피하기'라는 내용이 있습니다. 건강한 생활을 하려면 술자리는 되도록 피한다는 생활 수칙을 지키시기 바랍니다.

실천 방법 알기

술은 하루에 3잔 이상 마시지 않습니다.

- 주중에 상관없이 술을 대략 하루에 3잔 이상 마시면 심방세동 발생 위험도가 유의미하게 증가한다고 알려져 있으므로 건강한 심장을 유지하려면 술을 하루에 3잔 이상 마시는 일은 절대 삼가야 합니다.

술을 마실 때 폭탄주와 '원샷'은 피합니다.

- 술을 마시더라도, 소주나 양주 등 알코올 농도가 높은 술을 맥주나 에너지 음료와 섞어 마시는 '폭탄주'는 체내 알코올 흡수율과 전체 음주량을 높이므로 지양해야 합니다. 또한 잔에 든 술을 한 번에 마시는 '원샷'은 혈중 알코올농도를 급상승시키고, 폭음으로 이어질 확률을 높이므로 역시 지양해야 할 음주 습관이라고 할 수 있습니다.

참고 문헌

- ① 오세일. 술, 담배, 커피와 부정맥: 심방세동에 미치는 영향. Int J Arrhythm 2009;10(2):22-23.
- ② Djousse L, Levy D, Benjamin EJ, et al. Long-term alcohol consumption and the risk of atrial fibrillation in the Framingham Study. Am J Cardiol 2004;93(6):710-713.
- ③ Mukamal KJ, Tolstrup JS, Friberg J, et al. Alcohol consumption and risk of atrial fibrillation in men and women: the Copenhagen City Heart Study. Circulation 2005;112(12):1736-1742.
- ④ Mukamal KJ, Psaty BM, Rautaharju PM, et al. Alcohol consumption and risk and prognosis of atrial fibrillation among older adults: the Cardiovascular Health Study. Am Heart J 2007;153(2):260-266.
- ⑤ 보건복지부. 생활 속 절주 실천수칙. 2017.

과도한 스트레스를 피합니다

★★ 보통



실천 항목

- 스트레스를 관리하려면 본인에게 맞는 운동을 하며 건강한 생활 습관을 들이도록 노력합니다.
- 행동제어요법을 하며 과도한 스트레스를 피합니다.

관련 상식 들여다보기

- 스트레스는 교감신경을 자극하여 심방세동을 유발할 수 있습니다. 문헌에 따르면, 정신적 또는 육체적 스트레스는 심방세동을 약 30%까지 유발할 수 있다고 합니다. 또한 외상후스트레스장애를 겪는 군인 환자에게서 15% 정도 심방세동 발병이 보고되기도 하였습니다.
- 과도한 스트레스는 나쁜 생활 습관을 유도하여 심방세동을 유발하는 기폭제가 되기도 합니다. 반대로 심방세동에 따른 증상이나 관련된 치료가 정신적 스트레스를 유발 하기도 합니다.
- 스트레스는 우울증, 불안증을 유발할 뿐만 아니라 신체 활동 저하, 과음, 과식 등으로 체중이 증가하며, 과도한 카페인 섭취와 흡연 그리고 자기 관리 부족 등 전반적인 생활 습관을 악화시킵니다. 이러한 요인들이 심방세동을 유발하거나 재발 위험을 높입니다.
- 한 연구에 따르면, 발작성 심방세동 환자가 요가를 꾸준히 했더니 심방세동 재발률이 낮아졌다고 합니다. 또한 운동 후 혈압과 맥박이 낮아지고, 불안 증세가 감소 하였으며, 이에 따라 삶의 질이 향상되었다고 합니다.

관련 상식 들여다보기

- 꾸준한 운동은 체중 감소를 유도하고, 혈압을 낮추며, 수면 무호흡증 위험을 줄입니다. 특히, 고혈압은 심장의 유연성을 떨어뜨려 심방세동 위험을 높이는데, 운동은 이 위험을 낮출 수 있습니다. 그 밖에, 운동은 절주와 금연 생활 습관 같은 건강한 습관을 들이는데 도움이 됩니다.
- ‘생체 자기 제어’는 스스로를 조절하는 방법으로 심박수가 안정화되는 효과를 볼 수 있습니다. 따라서 심방세동 치료의 하나로 이용됩니다.
- 명상은 스트레스 지수를 낮추는 좋은 방법입니다. 특히 명상을 계속해서 하면 맥박의 불규칙한 변화 정도가 줄어들어 심방세동에 따른 증상이 호전되기도 합니다.

실천 방법 알기

과도한 스트레스는 교감신경을 자극하여 심방세동을 유발하거나 심방세동의 재발 빈도를 높입니다.

- 스트레스로 교감신경이 자극되면 심방세동 증상인 두근거림이나 가슴 불편감이 자주 나타나며 약을 먹어도 맥박수 조절이 어려울 수 있습니다.
- 교감신경이 자극되면 불안증이나 우울증, 수면 장애 등의 증상이 따를 수 있습니다.
- 지속적으로 교감신경이 항진된 상태에서는 심방세동 이외에도 심근경색증, 심부전 등과 같은 여러 심장질환이 발생할 수 있습니다.
- 스트레스는 과도한 카페인 섭취나 흡연, 과음, 수면 장애로 이어질 수 있는데, 이들은 교감신경 항진 상태를 좀 더 악화시킵니다. 따라서 스트레스 관리가 필요합니다.

스트레스를 관리하려면 요가나 본인에게 맞는 유산소 운동을 하며 건강한 생활 습관을 들이도록 노력하는 것이 중요합니다.

- 요가는 운동과 명상을 동시에 할 수 있는 효과적인 스트레스 관리법입니다.
- 유산소 운동은 꾸준히 하는 것이 좋습니다. 운동은 체중을 줄이고, 혈압을 낮추며, 수면 무호흡증을 줄여 심방세동 발생 위험도를 낮추고 심방세동에 따른 합병증을 낮춥니다.
- 운동은 건강한 생활 습관을 들이는 데 도움을 줍니다.
- 과음, 과식, 흡연을 삼가고, 건강한 음식을 적당량 먹는 것이 좋습니다.

실천 방법 알기

과도한 스트레스를 피하려면 자기 몸을 스스로 조절하려고 노력하는 행동 제어 요법이 도움이 됩니다.

- 생체 자기 제어(바이오피드백)는 스스로 몸을 통제하고자 노력하는 치료 요법입니다. 깊이 호흡하거나 인위적으로 근육을 이완한다거나, 자기 체면, 명상 요법이 여기에 해당합니다. 이를 이용해 스트레스를 관리하는 것이 도움이 됩니다.
- 생체 자기 제어를 지속하게 되면 맥박수가 안정화되어 심방세동에 따른 증상을 줄일 수 있고, 건강한 정신 상태를 유지할 수 있으며, 삶의 질을 높일 수 있습니다.
- 스트레스로 경직된 신체를 이완하고 손상된 자율신경계 기능을 개선하려면 침 치료도 고려해 볼 수 있습니다.

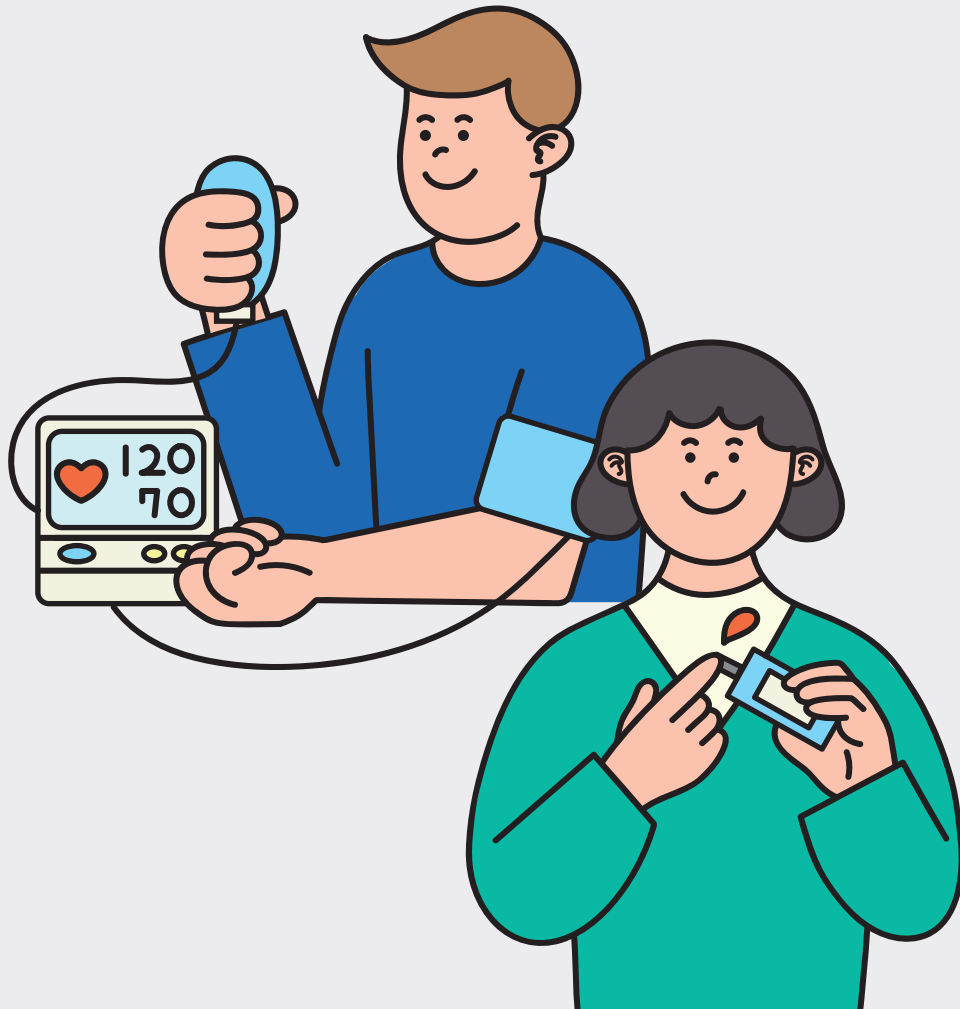
참고 문헌

- ① Segan L, Prabhu S, Kalman JM, et al. Atrial fibrillation and stress: a 2-way street?. JACC Clin Electrophysiol 2022;8(8):1051-1059.
- ② Lakkireddy D, Atkins D, Pillarisetti J, et al. Effect of yoga on arrhythmia burden, anxiety, depression, and quality of life in paroxysmal atrial fibrillation: the yoga my heart study. J Am Coll Cardiol 2013;61(11):1177-1182.
- ③ Tuladhar R, Bohara G, Grigolini P, et al. Meditation-induced coherence and crucial events. Front Physiol 2018;9:626.
- ④ Mattioli AV, Bonatti S, Zennaro M, et al. Effect of coffee consumption, lifestyle and acute life stress in the development of acute lone atrial fibrillation. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2008;9(8):794-798.
- ⑤ Kanmanthareddy A, Reddy M, Ponnaganti G, et al. Alternative medicine in atrial fibrillation treatment-Yoga, acupuncture, biofeedback and more. J Thorac Dis 2015;7(2):185-192.

4

고혈압이나 당뇨병 등과 같은 기저질환을 잘 관리합니다

★★★★ 높음



실천 항목

- 혈압을 자주 측정하여 목표 혈압이 유지되는지 확인합니다.
- 혈압약은 매일 같은 시간에 먹습니다.
- 본인의 당화혈색소를 확인합니다.

관련 상식 들여다보기

- 심방세동은 다양한 원인으로 발생합니다. 고령일수록 발생률이 높아지지만, 높은 혈압이 지속되거나 혈당 조절이 불량하여 고혈당이 계속되는 것은 심방세동 발생을 증가시킵니다. 이는 협심증, 뇌졸중 등의 위험한 심뇌혈관계 합병증의 발생뿐만 아니라 사망에 이르게 합니다. 고혈압에 따른 심방세동 발생은 남성에서 1.4배, 여성에서는 1.5배 높습니다. 관상동맥질환이 있는 고혈압 환자는 심방세동이 더 높게 발생합니다. 고혈압이 조절되지 않는 환자는 심장 내 압력이 만성적으로 높아져 좌심실이 두꺼워지는 좌심실 비대, 좌심방 확장이 유발되어 심방세동이 더 잘 발생합니다. 고혈압 환자는 여러 위험 요인에 따라 목표 혈압이 다르지만, 현재까지의 다양한 임상 연구를 보면 혈압이 적절하게 조절되면 심방세동과 관련한 위험도가 낮아진다고 알려져 있습니다.
- 당뇨병이 있는 환자의 심방세동 위험도는 당뇨병이 없는 성인보다 약 50% 높다고 알려져 있습니다. 혈압 조절이 잘되지 않는 당뇨병 환자도 혈관 손상을 포함한 다양한 원인으로 심장의 구조, 기능적 변화를 유발하여 심방세동이 발생하는 상태로 악화될 수 있습니다. 특히 당뇨병으로 치료받는 심방세동 환자는 심근경색증, 심부전, 뇌졸중 발생 위험이 최소 50% 이상 증가합니다. 따라서 당뇨병에서 혈당 조절의 지침이 되는 당화혈색소가 높아질수록 이러한 위험도는 더 높아지므로 심방세동 환자는 자기 혈당 수치가 잘 유지되고 있는지 늘 관심을 두고 지켜봐야 합니다.

실천 방법 알기

혈압을 자주 측정하여 목표 혈압으로 유지되는지 확인합니다.

- 고혈압에서 혈압 측정은 가장 기본적인 과정입니다. 혈압은 다양한 자세, 시간, 활동, 카페인, 음주, 흡연이나 심리적 상태에 따라 늘 변합니다.
- 한 달이나 두세 달에 한 번 병원에서 측정한 혈압은 정확하지 않을 수 있습니다. 의사는 평균적인 혈압의 상태를 보고 약제를 조절하거나 생활 습관을 바꾸기를 권고합니다. 따라서 병원 밖 혈압(가정혈압) 측정이 중요합니다. 차분히 앉아 발과 등을 기대고 2~3분 안정을 취한 다음 혈압을 재야 합니다. 특히 아침에 일어나서 혈압약을 먹기 전과 저녁에 자기 전에 측정한 혈압은 매우 중요합니다.
- 혈압을 잘 기록하여 담당 의사와 상의합니다. 혈압 조절의 시작은 스스로 측정한 혈압이 기본입니다. 그리고 본인의 목표 혈압이 얼마인지 담당 의사에게 물어보고 확인하여 스스로 혈압을 조절하도록 노력하는 것이 첫걸음입니다.

실천 방법 알기

혈압약은 매일 같은 시간에 먹습니다.

- 요즘에 나오는 혈압약은 일부 약을 제외하면 하루 한 번만 먹어도 혈압 조절 효과가 높습니다. 절반 이상의 고혈압 환자는 두 개 이상의 약이 필요한 경우가 많아, 혈압 조절이 되지 않는 주요 원인은 약을 자주 먹지 않고 건너뛰기 때문입니다.
- 보통 오전에 혈압이 오르고 실제 이 시간에 심근경색증, 뇌졸중이 좀 더 많이 발생하므로 아침에 반드시 혈압약을 먹는 것이 좋습니다. 바쁜 아침 시간이라 약을 깜박 잊을 때도 있겠지만 생각나는 즉시 먹어야 합니다. 혹시 늦은 밤에 생각이 났다면 다음 날 아침에 복용할 수도 있겠지만, 가장 좋은 방법은 생각나는 즉시 먹는 것입니다.
- 일부 신장질환자나 지병이 많아 활동이 어려운 경우를 제외하면 2알 분량의 약을 짧은 간격으로 먹더라도 약제 이상 반응이 높아지지 않습니다. 이렇게 약을 잘 먹으면 혈압도 조절이 잘될 가능성이 큼니다.

실천 방법 알기

본인의 당화혈색소를 확인합니다.

- 당뇨병 환자들은 여러 걱정으로 혈당을 자주 잹니다. 아무래도 아침 식사 전 공복혈당에 관심이 많습니다. 혈당은 식사량, 식사 종류, 활동에 따라 변합니다. 가장 이상적인 상태는 혈당이 너무 낮지 않은 공복혈당에서 적절한 식사 후에 혈당 수치가 200mg/dL이 넘지 않으면서 하루 동안 안정되는 것이 좋겠지만, 이는 사실 매우 어렵습니다. 또한 하루 4~6번 혈당 측정도 어렵습니다. 그러다 보니 의사들은 당화혈색소를 중요한 기준으로 봅니다. 이 수치가 높을수록 혈당이 잘 조절되지 않는 것으로 보아 약물 치료의 기준으로 삼습니다.
- 심장, 혈관에 가장 좋은 수치는 일반적으로 6.5% 이내이고 적어도 7% 미만이 좋습니다. 물론 나이나 환자 상태에 따라 목표 수치가 올라갈 수 있으나 적어도 본인이 당뇨병 환자라면 본인의 당화혈색소가 얼마인지, 잘 조절되고 있는지 물어보고 기억해야 합니다. 잘 조절된 당화혈색소는 심방세동을 넘어 나의 혈관 건강을 의미합니다.

참고 문헌

- ① 강남호. 고혈압과 부정맥. Journal of Cardiac Arrhythmia 2009;10(2):11-14.
- ② Fangel MV, Nielsen PB, Kristensen JK, et al. Glycemic status and thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation and type 2 diabetes mellitus: a danish cohort study. Circ Arrhythm Electrophysiol 2019;12(5):e007030.
- ③ 대한고혈압학회. 2022년 고혈압 진료지침. 2022.
- ④ 대한당뇨병학회. 2023 당뇨병 진료지침 제7판. 2023.
- ⑤ 대한부정맥학회. 심방세동 진료지침. 2021.

5

수면 무호흡을 잘 관리합니다

★★★★ 높음



실천 항목

- 수면 무호흡증과 심방세동 발생을 줄이려면 적절한 체중 유지가 중요합니다.
- 잠을 충분히 자도 낮에 계속 피곤하고 나른하다면 수면 검사를 받습니다.
- 저녁 식사 시간 이후 음식물 섭취를 피하고 가벼운 운동을 합니다.

관련 상식 들어다보기

- 심방세동을 일으키는 요인으로 고혈압, 심부전, 당뇨병을 들 수 있는데, 수면 무호흡증 또한 영향을 줍니다.
- 비만, 남성, 고혈압, 심부전 환자에게서 수면 무호흡이 잘 발생하며 나이가 증가하는 것 자체로도 위험 요인이 됩니다.
- 수면 무호흡 상태는 혈액의 산소를 떨어뜨리고 흉곽에 압력을 높이며 교감신경계 활성화를 유발하는데, 이런 상황이 오래 지속되면 심방의 구조와 기능을 변경하여 심방세동이 잘 생긴다고 알려져 있습니다.
- 비만은 이러한 상황과 밀접하게 연관되어 있습니다. 체중 감량, 규칙적인 운동과 음주를 조절하는 생활 습관 교정이 비만 예방이나 치료에 도움이 됩니다.
- 잠을 잘 때 심하게 코를 골거나, 잠을 충분히 잔 것 같지만 낮 활동 시간에 피곤함이 지속되고 집중이 어려운 경우에는 수면 무호흡증을 의심해 볼 수 있습니다. 약을 먹는 고혈압 환자 중에 혈압 조절이 잘되지 않고 혈압이 계속 높은 경우에는 수면 무호흡증이 심방세동 발생의 중요한 원인인 것으로 알려져 있습니다.
- 정확한 진단을 하려면 다면 수면 무호흡 검사가 필요합니다. 하루 정도 병원에서 잠을 자며 여러 가지 측정 검사를 하면 쉽게 진단할 수 있습니다.
- 심방세동 환자가 수술적 치료를 받았거나 수면 무호흡증 환자가 양압기 치료를 받으면 심장 박동이 정상 박동을 유지하는 데 도움이 된다고 알려져 있습니다.

실천 방법 알기

수면 무호흡증과 심방세동 발생을 줄이려면 적절한 체중 유지가 중요합니다.

- 자신의 적절한 체중[키(cm)-100]×0.9]을 알고 식이 조절, 운동을 통하여 적절한 범위로 조절합니다.

잠을 충분히 자도 낮에 계속 피곤하고 나른하다면 수면 검사를 받습니다.

- 잠을 자는 중에는 스스로 수면 상태를 알 수 없습니다. 동거인의 관찰도 도움이 되겠지만, 정확한 상태를 알려면 1박 2일 정도 시간이 소요되는 수면다원검사를 받아야 합니다. 최근에는 모바일 기기를 이용하여 정보를 얻을 수도 있지만 아직은 검증이 부족합니다.

저녁 식사 시간 이후 음식물 섭취를 피하고 가벼운 운동을 합니다.

- 수면 무호흡뿐만 아니라 수면의 질을 높이려면 밤에는 음식 섭취를 피하고 가벼운 운동을 합니다. 고혈압이나 당뇨병, 심장이나 뇌혈관 질환 발생에도 예방 효과가 있습니다.

참고 문헌

- ① Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2021;42(5):373-498.
- ② Yang PS, Ryu S, Kim D, et al. Variations of prevalence and incidence of atrial fibrillation and oral anticoagulation rate according to different analysis approaches. Sci Rep 2018;8(1):6856.
- ③ Stevenson IH, Teichtahl H, Cunningham D, et al. Prevalence of sleep disordered breathing in paroxysmal and persistent atrial fibrillation patients with normal left ventricular function. EHJ 2008;29(13):1662-1669.
- ④ Kanagala R, Murali NS, Friedman PA, et al. Obstructive sleep apnea and the recurrence of atrial fibrillation. Circulation 2003;107(20):2589-2594.
- ⑤ Fein AS, Shvilkin A, Shah D, et al. Treatment of obstructive sleep apnea reduces the risk of atrial fibrillation recurrence after catheter ablation. J Am Coll Cardiol 2013;62(4):300-305.

금연을 합니다

★★★★ 높음



실천 항목

- 금연을 합니다.
- 금연을 위한 건강한 생활 습관을 지니도록 합니다.
- 금연이 어렵다면 금연 교실, 금연 약물 등과 관련해 담당 의사와 상의합니다.

관련 상식 들어다보기

- 비만, 음주, 흡연과 운동 등 많은 생활 습관이 심방세동 발생 위험을 높입니다.
- 담배에 있는 니코틴 성분이 심장에서 빈맥(맥박이 자주 뛰는 일) 발생을 늘리고, 심장의 섬유화를 일으켜 심방세동 발생에 직간접적으로 관여합니다.
- 금연하면 흡연자보다 뇌졸중 등 심각한 심뇌혈관질환 발생 위험도를 100명 중 35명을 줄입니다. 그중 뇌졸중은 100명 중 41명을 줄이고, 관상동맥질환은 100명 중 25명을 줄입니다.
- 흡연은 심방세동 합병증과 증상 악화와 관련이 있으므로 금연을 해야 합니다. 따라서 금연은 치료와 예후에 매우 중요합니다.

실천 방법 알기

흡연은 심방세동의 위험 인자이므로 금연합니다.

- 흡연은 심방세동의 발생 위험을 늘리며 심방세동의 합병증인 뇌졸중, 관상동맥질환의 위험을 높이고 증상을 악화시킵니다.

흡연은 조절할 수 있는 위험 인자이므로 금연을 위한 건강한 생활 습관을 지니도록 합니다.

- 금연, 체중 감량, 금주, 운동 등의 좋은 생활 습관은 심방세동 예방과 심혈관 건강을 증진합니다.

금연이 어렵다면 금연 교실, 금연 약물 등과 관련해 담당 의사와 상의합니다.

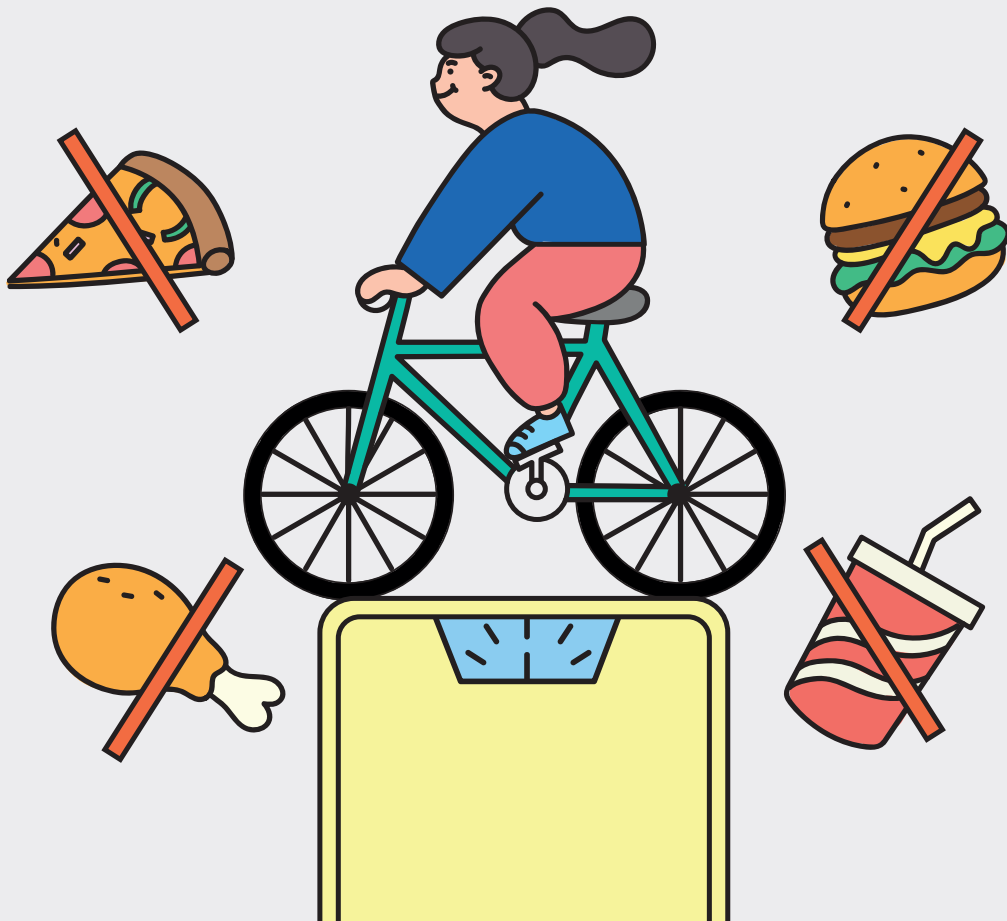
- 흡연은 약물 중독 중 하나이므로 본인 의지대로 금연 하기가 어렵다면 금연할 수 있도록 금연 교실, 금연 약물 등과 관련해 담당 의사와 상의합니다.

참고 문헌

- ① Hayashi H, Omichi C, Miyauchi Y, et al. Age-related sensitivity to nicotine for inducible atrial tachycardia and atrial fibrillation. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003;285(5):H2091-H2098.
- ② Goette A, Lendeckel U, Kuchenbecker A, et al. Cigarette smoking induces atrial fibrosis in humans via nicotine. Heart 2007;93(9):1056-1063.
- ③ Chamberlain AM, Agarwal SK, Folsom AR, et al. Smoking and incidence of atrial fibrillation: results from the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. Heart Rhythm 2011;8(8):1160-1166.
- ④ Choi S, Chang J, Kim K, et al. Association of smoking cessation after atrial fibrillation diagnosis on the risk of cardiovascular disease: a cohort study of South Korean men. BMC Public Health 2020;20(1):168.

비만을 관리합니다

★★★★ 높음



실천 항목

- 건강한 식습관을 유지합니다.
- 매일 20분 이상 걷기를 실천합니다.
- 하루 7~8시간의 충분한 수면 시간을 지킵니다.

관련 상식 들어다보기

- 심방세동을 진단받은 비만한 사람이나 비만하지 않은 사람 모두 심장을 건강하게 관리하려면 적절한 몸무게를 유지해야 합니다. 비만이 심방세동에 주는 좋지 않은 영향은 이미 많은 연구로 알려져 있는데, 반대로 체중을 감량했을 때의 긍정적인 영향도 조명되고 있습니다.
- 미국 매사추세츠주 프레이밍햄 지역에서 약 5,000명 이상의 주민을 20여 년간 추적한 연구에 따르면, 비만한 성인은 정상체중의 성인보다 심방세동이 발생할 확률이 50% 이상 증가하는 것으로 나타났습니다. 반대로, 최소한 과체중이면서 심방세동이 있는 355명의 성인을 5년 동안 지켜본 연구에서 몸무게의 10% 이상을 감량했을 때 부정맥 없이 생존하는 기간이 6배 이상 늘어나는 것을 확인하였습니다. 이런 연구들로 비만이 심방세동에 좋지 않은 영향을 준다는 것을 알 수 있습니다.

관련 상식 들여다보기

- 비만은 심방세동이 일어나는 원인 중 하나이지만 조절 가능하다는 점에서 매우 중요합니다. 심장은 좌측과 우측으로 나눌 수 있고, 위쪽에 있는 심방과 아래쪽에 있는 심실로도 나눌 수 있습니다. 좌측의 심방이 커진 상태가 심방세동에 영향을 끼치며 비만은 좌측 심방이 커지는 것과 관련이 깊습니다. 또한 심장의 막을 둘러싼 지방층이 커지면서 심장 안으로 지방침윤이 일어나면 구조적인 이상을 가져와 부정맥이 발생하기 쉬운 상태가 되기도 합니다.
- 비만한 성인이 몸무게를 줄이거나 정상체중을 유지하려면 생활 습관을 건강하게 바꾸고 이를 유지해야 합니다. 건강한 식단, 적절한 운동, 충분한 수면과 같은 일상생활에서 교정 가능한 방법들로 건강한 몸무게를 유지하도록 합니다.

실천 방법 알기

건강한 식습관을 유지합니다.

- 효과적으로 몸무게를 줄이고 유지하기 위해서는 자신의 체질량 지수를 알고, 필요한 칼로리량을 계산하여 개인의 생활 습관에 가장 적절한 식단을 계획하고 실천해야 합니다.
- 개인의 식습관을 파악하기 가장 좋은 방법은 식사 일기를 적는 것입니다. 하루 동안 섭취한 모든 음식의 종류와 양을 적어 한 달 치를 모아 보면 본인의 식사 습관을 쉽게 파악할 수 있습니다. 식사 일기에 자주 등장하는 나쁜 음식은 되도록 피하고, 건강한 음식은 더욱 다양하게 섭취하도록 합니다. 건강상의 이유로 식사 일기 작성이 어렵다면 우선 짠 음식, 단 음식, 기름진 음식을 줄이고 물을 충분히 마시는 습관을 기르는 것이 좋습니다.

실천 방법 알기

매일 20분 이상 걷기 운동을 합니다.

- 미국심장학회에 따르면 일주일에 150분 이상(하루에 20분 이상) 걷기 운동을 하면 비만을 예방하고 심장 질환을 줄인다고 합니다. 생활권 주변의 체육시설을 이용하여 걷기 운동을 꾸준히 실천하도록 합니다.
- 걷기의 속도는 옆 사람과 대화가 약간 힘든 정도의 속도로 시간당 5km 정도의 속력으로 실천할 것을 권장합니다. 걷기와 같이 매일 실행할 수 있는 무리 없는 운동을 하여 근육을 단련시키면 기초대사율이 올라가 지방을 더 잘 태울 수 있습니다. 심한 무릎관절염과 같이 걷기 운동이 오히려 건강에 무리가 될 때에는 담당 의사의 판단에 따라 부담이 덜 되는 다른 운동으로 대체하는 것이 좋습니다.

실천 방법 알기

하루 7~8시간의 충분한 수면 시간을 지킵니다.

- 충분한 수면을 유지하는 것은 체중 관리에 중요합니다. 잠을 충분히 자지 못하면 배고픔을 느끼게 하는 호르몬은 증가하고, 포만감을 느끼게 하는 호르몬은 감소하여 건강한 식생활을 유지하는 것이 힘들어지기 때문입니다.
- 하루 7~8시간의 수면은 심혈관질환 예방에 효과적인 것으로 알려져 있습니다. 질 좋은 수면을 유지하려면 잠드는 시간과 기상 시간을 일정하게 해야 합니다. 저녁 시간에는 카페인 들어 있는 음식을 피하고, 잠에 들기 위해 술을 마시지 않으며, 잠자기 전에는 과도한 식사나 수분 섭취를 제한하는 등의 수면위생을 지켜야 합니다. 잠드는 데 30분 이상 시간이 걸리거나 잠든 후 자주 깨는 등의 수면장애가 있다면 단기간의 약물치료가 도움이 됩니다.

참고 문헌

- ① Wang TJ, Parise H, Levy D, et al. Obesity and the risk of new-onset atrial fibrillation. JAMA 2004;292(20):2471-2477.
- ② Pathak RK, Middeldorp ME, Meredith M, et al. Long-term effect of goal-directed weight management in an atrial fibrillation cohort: A Long-Term Follow-Up Study (LEGACY). J Am Coll Cardiol 2015;65(20):2159-2169.
- ③ Asad Z, Abbas M, Javed I, et al. Obesity is associated with incident atrial fibrillation independent of gender: A meta-analysis. J Cardiovasc Electrophysiol. 2018;29(5):725-732.
- ④ 2020 한국인 영양소 섭취기준. 보건복지부.
- ⑤ 2022 국민생활체육조사. 문화체육관광부.
- ⑥ Kwok CS, Kontopantelis E, Kuligowski G, et al. Self-reported sleep duration and quality and cardiovascular disease and mortality: A dose-response meta-analysis. J Am Heart Assoc 2018;7(15):e008552.
- ⑦ Liu S, Wang X, Zheng Q, et al. Sleep deprivation and central appetite regulation. Nutrients 2022;14(24):5196.
- ⑧ 대한수면학회 홈페이지(sleepmed.or.kr).

심방세동으로 진단받으면 반드시 적절한 치료를 받습니다

★★★★ 높음



실천 항목

- 증상이 심하지 않더라도 뇌졸중, 심혈관질환 등 합병증을 예방하려면 정기적인 진료를 받습니다.
- 심방세동을 치료하려고 약물치료를 받는다면 약물 순응도와 지속성을 유지합니다.

관련 상식 들어다보기

- 심방세동은 가장 흔한 부정맥으로 다른 나라에서 유병률은 100명 중 2~4명으로 추정되고, 우리나라는 100명 중 1~1.5명으로 파악되고 있습니다.
- 심방세동으로 인한 연령 보정 사망률이 인구 10만 명당 6.5명으로 사망이 증가한 이유는 심부전, 동반 질환의 악화, 뇌졸중 등이 원인인 것으로 보입니다.
- 심방세동은 허혈성 뇌졸중, 원인불명 뇌졸중, 심부전, 혈전색전증, 인지기능 저하, 혈관성 치매, 우울증 등을 동반하고, 환자 100명 중 60명은 삶의 질 저하를 호소합니다.
- 심방세동의 포괄적인 치료는 뇌졸중 예방, 증상과 심장 리듬 관리, 동반 질환과 합병증 관리에 목표를 두고 있습니다.

참고 문헌

- 1 Benjamin EJ, Muntner P, Alonso A, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2019 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation* 2019;139(10):e56-e528.
- 2 Lee SR, Choi EK, Han KD, et al. Trends in the incidence and prevalence of atrial fibrillation and estimated thromboembolic risk using the CHA2DS2-VASc score in the entire Korean population. *Int J Cardiol* 2017;236:226-231.
- 3 Lee SR, Choi EK, Han K, et al. Prevalence of non-valvular atrial fibrillation based on geographical distribution and socioeconomic status in the entire Korean population. *Korean Circ J* 2018;48(7):622-634.
- 4 Kim D, Yang PS, Jang E, et al. 10-year nationwide trends of the incidence, prevalence, and adverse outcomes of non-valvular atrial fibrillation nationwide health insurance data covering the entire Korean population. *Am Heart J* 2018;202:20-26.
- 5 Lip GYH. The ABC pathway: an integrated approach to improve AF management. *Nat Rev Cardiol* 2017;14(11):627-628.

실천 방법 알기

심방세동을 치료하지 않으면 뇌졸중, 심혈관질환 등 합병증 발생 위험이 높아집니다.

- 심방세동으로 진단받으면 뇌졸중, 심혈관질환 등 합병증 발생 위험을 예방해야 하므로 정기적인 진료를 받아야 합니다. 또한 심방세동을 악화시키는 요인들을 파악하여 교정해야 합니다.

심방세동을 치료하지 않으면 두근거림, 호흡곤란 등의 증상이 발생하여 일상생활에 지장을 초래하고 입원 치료가 필요하며, 삶의 질도 떨어집니다.

- 심방세동 치료를 받는 중에 두근거림, 호흡곤란 등의 증상이 발생하여 일상생활에 지장을 초래하면 즉시 담당 의사의 진료를 받으며 철저히 관리합니다. 증상이 악화되었을 때 적절한 치료를 받지 않으면 입원을 하여 치료를 받아야 하거나 사망할 확률이 높아질 수 있습니다.

심방세동을 치료하려고 약물치료를 받을 때 약물 순응도와 지속성이 유지되지 않으면 치료 예후가 나빠집니다.

- 심방세동을 치료하려고 치료 목표를 세우고, 뇌졸중, 심혈관질환 등 합병증 발생을 낮추려면 정기적으로 담당 의사와 상담합니다. 약물치료를 받을 때에는 약물 순응도와 지속성이 적절하게 유지되고 있는지 확인합니다.

심방세동 관련 자주하는 질문

- 가슴이 자주 두근거리는데 심방세동인가요? 53p
- 스마트워치에서 '심방세동'이라고 뜨는데 정말 심방세동이 생긴 건가요? 54p
- 심방세동을 예방할 수 있는 음식이나 약이 있나요? 54p
- 부정맥과 심방세동은 무엇이 다른가요? 55p

Q 가슴이 자주 두근거리는데 심방세동인가요?

A 가슴이 두근거리는 상황은 다양합니다. 정상 심장에서도 깜짝 놀라거나, 스트레스가 있거나, 뛰거나, 언덕이나 계단을 오를 때 가슴이 두근거리는 것은 당연한 생리적 반응이라 할 수 있습니다. '부정맥'은 심장 박동이 고르지 않은 모든 질환을 통틀어 말하는 것이고, 다양한 부정맥 질환에서 두근거림이 나타납니다. 따라서 두근거리는 증상이 수많은 부정맥 질환 중 심방세동과 연관된 것인지 확인하려면 심전도 검사를 해야 알 수 있습니다. 다시 한번 강조하지만, 심방세동은 '심전도' 검사를 해야만 확실한 진단을 받을 수 있습니다.

Q 스마트워치에서 '심방세동'이라고 뜨는데 정말 심방세동이 생긴 건가요?

A 아닙니다. 반드시 그런 것은 아니므로 걱정하지 않으셔도 됩니다. 스마트워치에서는 심방세동을 일찍 발견하려고 의심이 되는 불규칙한 리듬을 심방세동이라고 표시합니다. 정확한 진단은 담당 의사와 상담하고 진찰, 심전도 검사 등으로 확인할 수 있습니다.

Q 심방세동을 예방할 수 있는 음식이나 약이 있나요?

A 지중해식 식단이나 고혈압 예방과 조절을 위한 저염식과 채식 위주의 식단(DASH 식단)이 효과가 있을 것으로 보이지만, 이는 심방세동 예방에 직접 도움이 된다고보다는 심방세동 발병의 위험 요소인 비만, 고혈압, 관상동맥질환 등의 예방에 도움이 되는 간접적인 효과로 판단됩니다. 다시 말해 직접적으로 심방세동을 예방해 주는 음식은 없지만, 즉석음식 등은 피하고 건강한 식단을 유지하며 금주를 실천하고 적절한 운동 등을 하면 심방세동 예방에 도움이 됩니다.

Q 부정맥과 심방세동은 무엇이 다른가요?

A 부정맥은 심장의 리듬이 비정상적인 모든 질환을 통칭합니다. 부정맥은 누구나 한 번쯤 경험했을 법한 흔하고 가벼운 질환부터 발생 즉시 급사하는 위험한 질환까지 다양한 것을 포함합니다. 심방세동은 이 부정맥 중 하나의 질환입니다.



개발 개요

개발자	2023 심방세동 임상진료지침 제정위원회 및 개발위원회
사용자	일반인 및 심방세동 환자
외부검토	사용자 30명
목적	근거를 기반으로 심방세동 예방·관리 수칙과 실천 방법 그리고 자주하는 질문에 대하여 꼭 필요한 정보를 제공하여 국민이 심방세동과 관련한 위험 요인을 보다 쉽게 이해하고, 건강한 생활을 유지하는 것이 중요하다는 인식을 높이고자 함.
개발영역	• 심방세동 소개 • 심방세동 예방과 관리 8대 생활 수칙 • 심방세동 자주하는 질문
예상편익	뇌경색의 위험도 예측, 뇌졸중 위험 및 발생률 감소, 리듬 조절 관련 부작용의 발생 감소, 전신 색전증 예방, 출혈 합병증 예방, 심부전 악화 예방, 심근경색 예방, 삶의 질 향상 등

개발방법

의사용 진료지침(일차 의료용 근거기반 심방세동 권고 요약본, 일차 의료용 근거기반 심방세동 임상진료지침)과 같은 근거자료를 사용하여 다학제 전문가들이 개발함.

사용자 의견조사 및 결과의 반영

사용자 의견조사 기간: 2023. 11. 29 ~ 12. 06
이 지침의 주 사용자인 일반인 30명을 대상으로 「나와 가족을 위한 심방세동 예방과 관리 정보」의 필요도와 활용도에 대한 의견조사를 수행한 후 반영함.

편집의 독립성

- 재정지원: 질병관리청 만성질환예방과의 「일차 의료용 만성질환 임상진료지침 정보센터 운영지원」 사업의 하나로 국민건강증진기금 민간경상보조사업비를 지원받았으며, 재정 지원자가 나와 가족을 위한 심방세동 예방과 관리 정보의 내용이나 개발 과정에 직접적인 혹은 잠재적인 영향을 주지 않음.
- 개발에 참여한 모든 구성원의 잠재적인 이해 상충 관계 유무를 확인하고자 자기기입식 조사표를 개발하여 지난 2년 동안 지침개발 내용과 관련된 주제로 1,000만 원 이상의 후원을 받거나, 사례금을 받고 자문했거나, 특정 기관 혹은 제약회사의 지분 이익이나 주식 매수권과 같은 경제적 이익에 대한 권리를 제공받았는지, 개발에 참여한 구성원이 특정 기관 혹은 제약회사에서 공식적 또는 비공식적인 직함을 가졌는지 등을 조사하였고 상충하거나 혹은 잠재적인 이해관계는 없었음.

갱신의 원칙과 방법

3~5년마다 의사용 진료지침을 개정할 경우, 같은 근거 자료를 사용하는 「나와 가족을 위한 심방세동 예방과 관리 정보」를 개정할 예정임.

관련 정보 찾아보기

일차 의료용 근거기반 디지털 가이드라인
(www.digitalcpg.kr) 누리집에 접속



집필진

심방세동 임상진료지침 제정위원회 2023

구분	추천 학회명	성명	소속	전문과목
위원장	대한부정맥학회	오세일	서울대학교병원	순환기내과
간사	대한부정맥학회	진은선	강동경희대학교병원	심장혈관내과
위원	대한뇌졸중학회	박홍균	인제대학교 일산백병원	신경과
위원	대한고혈압학회	최성훈	한림대학교강남성심병원	순환기내과
위원	대한갑상선학회	임동준	가톨릭대학교 서울성모병원	내분비내과
위원	대한당뇨병학회	김종화	부천세종병원	내분비내과
위원	대한신장학회	서상헌	전남대학교병원	신장내과
위원	대한내과학회	황희정	강동경희대학교병원	심장혈관내과
위원	대한가정의학회	신정화	고려대학교 안산병원	가정의학과
위원	대한개원의협의회	한경일	서울내과의원	순환기내과
간사	대한의학회	신인순	대한의학회 연구센터	보건학(방법론)

심방세동 임상진료지침 개발위원회 2023

구분	추천 학회명	성명	소속	전문과목
위원장	대한부정맥학회	오세일	서울대학교병원	순환기내과
간사	대한부정맥학회	진은선	강동경희대학교병원	심장혈관내과
위원	대한부정맥학회	고점석	원광대학교병원	순환기내과
위원	대한부정맥학회	박준범	이대목동병원	순환기내과
위원	대한부정맥학회	백용수	인하대학교병원	심장내과
위원	대한부정맥학회	신승용	고려대학교 안산병원	순환기내과
위원	대한부정맥학회	심재민	고려대학교 안암병원	순환기내과
위원	대한부정맥학회	유희태	세브란스병원	심장내과
위원	대한부정맥학회	이대인	충북대학교병원	심장내과
위원	대한부정맥학회	이소령	서울대학교병원	순환기내과
위원	대한부정맥학회	이영수	대구가톨릭대학교병원	순환기내과
위원	대한뇌졸중학회	박홍균	인제대학교 일산백병원	신경과
위원	대한고혈압학회	최성훈	한림대학교강남성심병원	순환기내과
위원	대한갑상선학회	임동준	가톨릭대학교 서울성모병원	내분비내과

구분	추천 학회명	성명	소속	전문과목
위원	대한당뇨병학회	김종화	부천세종병원	내분비내과
위원	대한신장학회	서상헌	전남대학교병원	신장내과
위원	대한내과학회	황희정	강동경희대학교병원	심장혈관내과
위원	대한가정의학회	신정화	고려대학교 안산병원	가정의학과
위원	대한개원의협의회	한경일	서울내과의원	순환기내과

대한의학회 임상진료지침 연구사업단 2023

구분	성명	소속
회장	정지태	대한의학회 회장, 고려대 병원
단장	이진우	대한의학회 부회장, 연세대 병원
부단장	용환석	대한의학회 정책이사, 고려대 병원
연구위원	신인순	대한의학회 연구센터 실장
선임연구원	김다솔	대한의학회 연구센터
선임연구원	유경미	대한의학회 연구센터
연구원	전정진	대한의학회 연구센터
연구원	백중서	대한의학회 연구센터

개발 참여 학회

심방세동 예방과 관리 정보 개발 및 발행	대한의학회
심방세동 예방과 관리 정보 개발 주관학회	대한부정맥학회
심방세동 예방과 관리 정보 개발 참여학회	대한뇌졸중학회 대한고혈압학회 대한갑상선학회 대한당뇨병학회 대한신장학회 대한내과학회 대한가정의학회 대한개원의협의회

나와 가족을 위한
심방세동 예방과 관리 정보

발행일	2024년 4월
펴낸곳	대한의학회·질병관리청
개발·집필	대한의학회 심방세동 임상진료지침 제정위원회 및 개발위원회
기획·편집	대한의학회 임상진료지침 연구사업단 서울시 서초구 반포대로 14길 42(서초동) 하이앤드빌딩 6층 (우.06653) 전화. 02-6952-9602 전자우편. guidelines@kams.or.kr
디자인	더디앤씨 www.thednc.co.kr



「나와 가족을 위한 심방세동 예방과 관리 정보」는 질병관리청 만성질환예방과의 「일차 의료용 만성질환 임상진료지침 정보센터 운영지원」 사업의 하나로 국민건강증진기금 민간경상보조사업비를 지원받아 제작되었습니다.



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청



비매품/무료

95510



9 791168 603424

ISBN 979-11-6860-342-4 (PDF)